



Hand-off in perioperative care

พว. สударัตน์ ศรีสมุทธนาค
งานการพยาบาลผ่าตัด โรงพยาบาลศิริราช

HAND-OFF COMMUNICATION

- hand-off
- handover
- sign-over
- shift report

“hand off” : the transfer of *patient information*, along with the authority and responsibility to care for that patient, *from one health care provider to another* during the transfer of care

Hand-off

การส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย หมายถึง กระบวนการสื่อสารแบบมีปฏิสัมพันธ์ **ระหว่างพยาบาลห้องผ่าตัด** ด้วยกันเอง และระหว่าง **พยาบาลห้องผ่าตัดกับพยาบาลประจำหอผู้ป่วยหรือวิสัญญีพยาบาล** เพื่อส่งต่อข้อมูลของผู้ป่วยที่สำคัญ รวมถึงความรับผิดชอบและบทบาทในการจัดการดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ต่อเนื่อง (Continuity of care) และมีความปลอดภัย (Patient safety)



(รัตใจ เวชประสิทธิ์, 2012)

Hand-off

Joint commission on accreditation of healthcare organizations (JCAHO)

การส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย (handoff) หมายถึง กระบวนการสื่อสารที่สามารถมีการตอบสนองกันได้ทันทีในการส่งต่อข้อมูลที่สำคัญของผู้ป่วยจากผู้ดูแลคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง หรือจากทีมการรักษาทีมหนึ่งไปยังอีกทีมหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและความปลอดภัยในการให้การดูแลผู้ป่วย

Ex: hand off in the OR

- from one *RN circulator* to another *RN circulator*
- from one *scrub person* to another *scrub person*
- from *surgeon* to *scrub nurse*

♥ The “hand-off communication report” must be

- complete
- concise
- concrete
- clear
- accurate



Comparison of Original and Revised Hand-Over Communication Tool Topics and Associated Responses , **electronic health record (EHR)** (Hospital of the University of Pennsylvania, USA.2021)

Original Tool		Revised Tool	
Topic	Documentation Response	Topic	Documentation Response
Procedure	Yes / No	Name and date of birth	Reviewed
Surgeon plan and preferences	Yes / No	Allergies	Reviewed
Anesthesia type	Yes / No	Specific patient considerations • Metal implants • Limb restrictions • Isolation • BMI > 40 • Interpreter needed • Belongings	Reviewed
Medical history and allergies	Yes / No	Procedure	Reviewed
Counts	Yes / No	Anesthesia type	Reviewed
Medications and irrigations	Yes / No	Positioning and skin integrity	Reviewed
Specimens	Yes / No	DVT prophylaxis	Reviewed
Special equipment and implants	Yes / No	Equipment, supplies, and implants	Reviewed
Catheters and invasive lines	Yes / No	Medications and irrigations • On field • Available	Reviewed
Skin integrity reviewed	Yes / No	Counts • Instrument sets used or available • Instruments added to the field • Supplies and instruments off field • Review of countable items	Reviewed
Family communication	Yes / No	LDAs	Reviewed
		Specimens	Reviewed
		Postoperative destination	Reviewed
		Family communication	Reviewed
		Documentation to be reviewed	Reviewed

BMI = body mass index; DVT = deep vein thrombosis; LDAs = lines, drains, and airways.

HAND-OFF SYSTEMS AND TECHNIQUES

- 1. SBAR:** situation, background, assessment, recommendation
- 2. PASS the BATON:** introduction, patient, assessment, situation, safety concerns, (the)background, actions, timing, ownership, next
- 3. SHARQ:** situation, history, assessment, recommendations, questions
- 4. Five Ps:** patient, plan, purpose of plan, problem, precaution
- 5. Five Ps, second version:** patient, precautions, plan of care, problems, purpose

Ex : " SWITCH for OR Hand Off "

(Providence St Vincent Medical Center, Portland, OR. USA,2013)

SWITCH for OR Hand Off

S Surgical procedure

- ☐ Diagnosis
- ☐ Stage of procedure (ie, beginning, middle, end)
- ☐ Specific patient concerns (eg, allergies, implants, health status)
- ☐ Imaging needed (eg, x-ray)
- ☐ Incision type/dressings needed
- ☐ Plan for postoperative patient disposition
- ☐ Procedure to follow

W Wet (ie, fluids)

- ☐ Medications on the sterile field (ie, type, amount)
- ☐ Irrigation (ie, type, amount)
- ☐ Blood loss and blood products available
- ☐ Urine out
- ☐ Drains

I Instruments

- ☐ Need to reprocess instruments for to-follow cases
- ☐ Instruments on hold
- ☐ Implants needed

T Tissue (ie, specimen)

- ☐ Specimen (ie, name, source of specimen)
- ☐ Grafts (ie, type, source of graft, location of graft [eg, specimen refrigerator, dry storage cabinet])
- ☐ Type of laboratory procedure (eg, frozen, touch prep)

C Counts

- ☐ Sponges, needles, sharps, and instruments
- ☐ Items off the sterile field or in body cavities

H Have you any questions?

- ☐ Status of charting?



hand off between

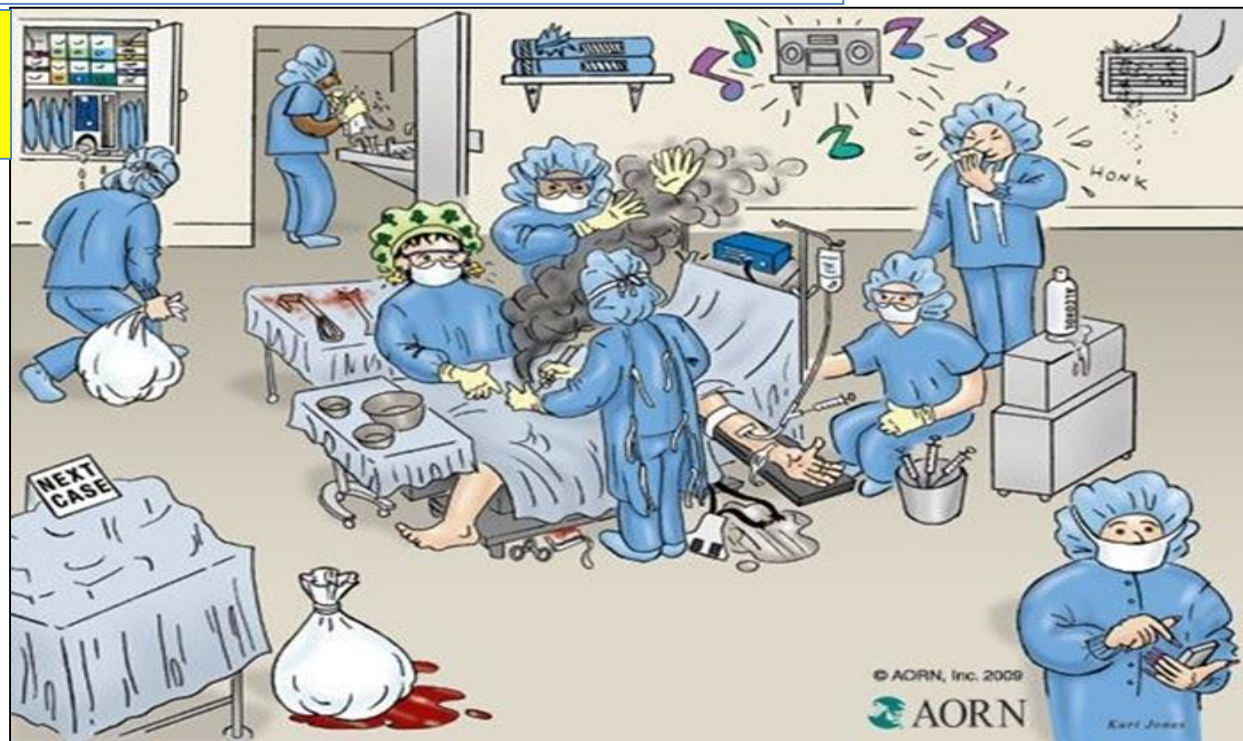
- two RN circulators
- scrub person to scrub person

1

SAFETY FIRST



2



Barriers to concise communication

1. inattention
2. information overload
3. multitasking
4. noise
5. stress
6. time pressures

(Johnson F, Logsdon P, Fournier K, et al. SWITCH for safety: perioperative hand-off tools. AORN J 2013;98:494–507.)



Enablers

Barriers



Fig. 2. Enablers and barriers to safe perioperative handoffs.



แผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

พ.ศ. 2566-2572

ฉบับปรับปรุง

วิสัยทัศน์

สถาบันการแพทย์ของแผ่นดิน ที่สร้างองค์ความรู้และบริการอันเป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพพระคดับโลก

เป้าหมาย

ผลงานวิจัยระดับโลก

โรงพยาบาลที่ประชาชนเชื่อมั่นมากที่สุดในประเทศ

รางวัลด้านการศึกษาระดับนานาชาติ

วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์

การวิจัย

เป็นแหล่งผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมระดับโลก

Siriraj Health System

เป็นระบบบริการทางการแพทย์ที่มุ่งเน้นการรักษาในทุกกระดับ
ถึงศักยภาพที่ยั่งยืน

การศึกษา

ผลิตบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ระบบการบริหารจัดการ เป็นสถาบันที่ขับเคลื่อนด้วยระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์

1

สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่มีผลกระทบสูงอย่างยั่งยืน

- 1.1 ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็น "Breakthrough"
- 1.2 ขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านนโยบาย
สังคม และเชิงพาณิชย์
- 1.3 สร้างระบบบริหารวิจัยและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

2

มุ่งบริการทางการแพทย์ แบบ Best Health Value

- 2.1 ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพที่มีมาตรฐานระดับสากล
- 2.2 พัฒนาเพื่อสนับสนุนพันธกิจคณะฯ อย่างยั่งยืน
- 2.3 ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- 2.4 สร้างองค์กรที่มีบุคลากรมีศักยภาพและทำงานด้วยใจ

3

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทางด้านการศึกษาวissenschaftสุขภาพ

- 3.1 มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการการศึกษา
- 3.2 สร้างนวัตกรรมของหลักสูตรการศึกษา
- 3.3 สร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการศึกษาในระดับนานาชาติ

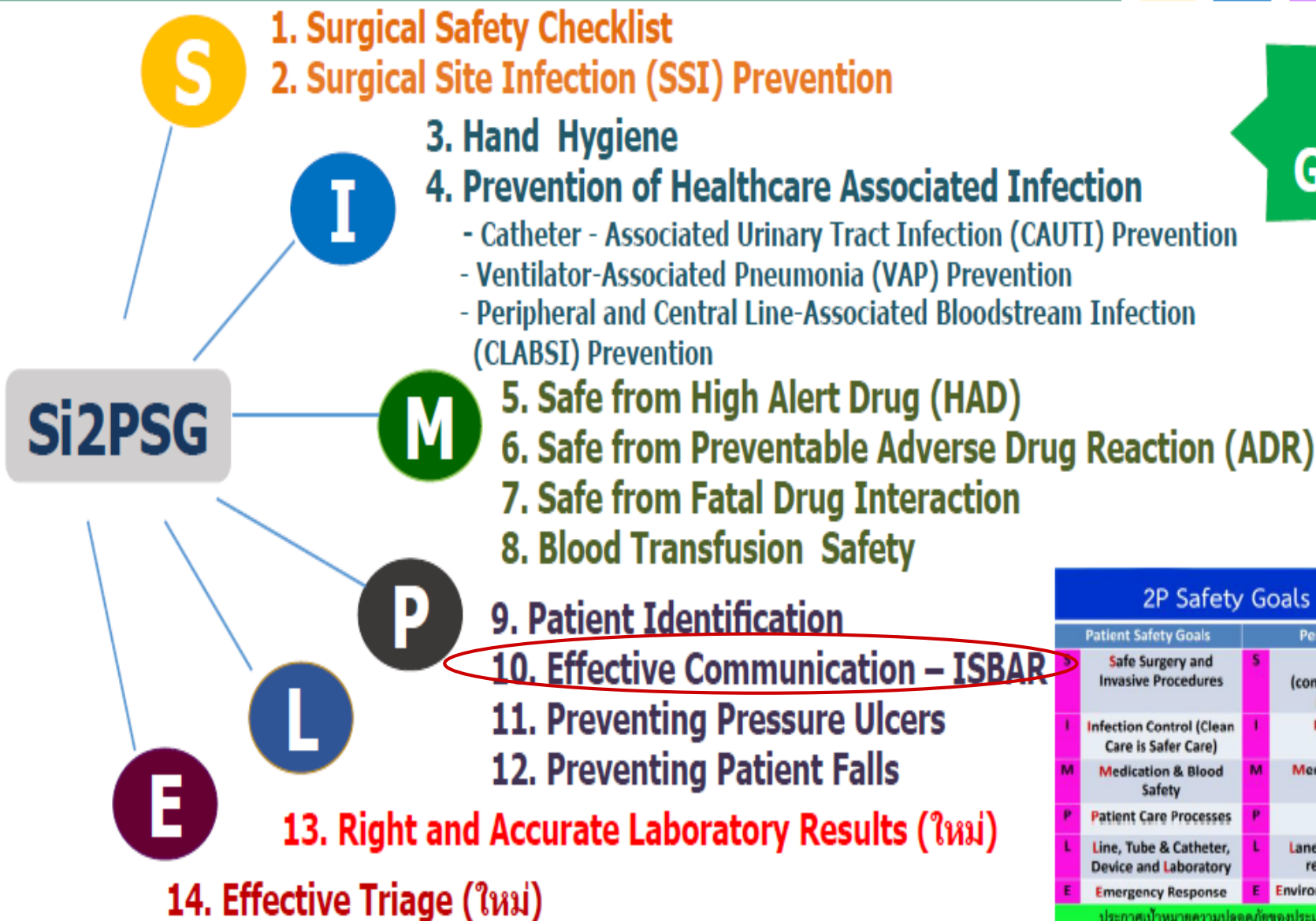
4

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

- | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|
| 4.1 มุ่งเน้นความมั่นคงปลอดภัย
และประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศ | 4.2 บริหารทรัพยากรบุคคล
ให้สามารถ พอเพียง และผูกพัน
ด้วยระบบสนับสนุนที่ทันสมัย | 4.3 สื่อสาร ส่งเสริมความเข้าใจต่อ
ธรรมาภิบาล | 4.4 พัฒนาระบบบริหารพัสดุ
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
เป็นเลิศ | 4.5 ยกระดับเสถียรภาพด้านการเงิน
และงบประมาณ | 4.6 มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม
และชุมชน |
|--|--|---|--|--|---|



14
Goals



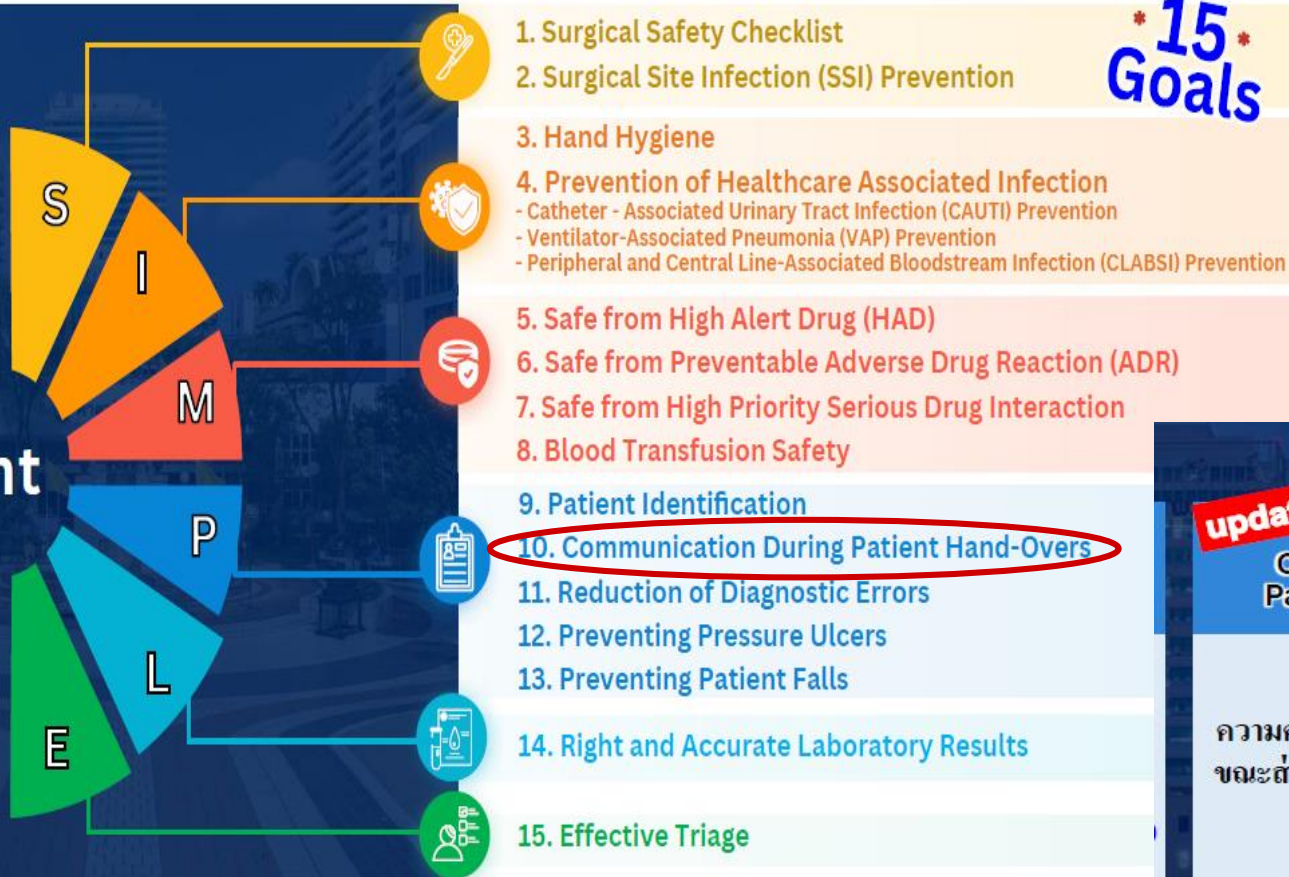
2P Safety Goals			
Patient Safety Goals		Personnel Safety Goals	
S	Safe Surgery and Invasive Procedures	S	Social Media (communication), Security and privacy of information
I	Infection Control (Clean Care is Safer Care)	I	Infection and Exposure
M	Medication & Blood Safety	M	Mental Health and Mediation
P	Patient Care Processes	P	Process of work
L	Line, Tube & Catheter, Device and Laboratory	L	Lane (ambulance), Legal Issues regulation (medical legal)
E	Emergency Response	E	Environment & Working conditions

ประกาศเป้าหมายความปลอดภัยของประเทศเพื่อผู้ใช้และผู้ให้บริการ

Siriraj 3P Safety Goals 2568 - 2570

15
Goals

Patient



update

Goal 10

**Communication during
Patient Care Hand-overs**

จำนวนอุบัติการณ์
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการสื่อสาร
ขณะส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย ระดับ E ขึ้นไป

0 ครั้ง



Effective Communication: ISBAR

ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการพัฒนางานบริการผู้ป่วยใน โรงพยาบาลศิริราช

ตัวชี้วัด (KPI) อุบัติการณ์การสื่อสารที่ไม่ใช้ ISBAR (ระดับ E ขึ้นไป) เท่ากับ 0 ครั้ง

ตัววัดกระบวนการ (PI)

1. อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึกใน Patient Transfer Record มากกว่าหรือเท่ากับ 80%
2. อัตราการลงลายมือชื่อแพทย์ในคำสั่งการรักษาทางโทรศัพท์ภายใน 24 ชั่วโมง เท่ากับ 100%

รายละเอียดของเนื้อหาที่สำคัญ/ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. ประกาศให้ทุกหน่วยงานรับทราบ เรื่องต่อไปนี้
 - 1) นโยบายเรื่องการสื่อสารโดยใช้ ISBAR
 - 2) วิธีปฏิบัติงาน เรื่องการรับคำสั่งการรักษาทางโทรศัพท์
 - 3) การใช้ Patient Transfer Record ตามแนวปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
2. ให้นายงานศึกษาวิดิทัศน์ 5 เรื่อง ได้แก่
 - 1) แนะนำการสื่อสารโดยใช้ ISBAR
 - 2) วิธีบันทึกใน Patient Transfer Record
 - 3) การส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
 - 4) การรับคำสั่งการรักษาทางโทรศัพท์
 - 5) การรายงานแพทย์ทางโทรศัพท์

Effective Communication: ISBAR

Do & Don't

1. ให้สื่อสารโดยใช้ ISBAR ระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพที่ร่วมดูแลผู้ป่วยในกรณีการส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การรับคำสั่งการรักษาทางโทรศัพท์ การรายงานแพทย์ทางโทรศัพท์ และการใช้ Patient Transfer Record เมื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
2. การรับคำสั่งการรักษาทางโทรศัพท์ ใช้เมื่อฉุกเฉินเท่านั้น
3. ให้รายงานอุบัติการณ์ โดยให้ผู้รายงาน ระบุสาเหตุจากการสื่อสารที่ไม่ใช่ ISBAR

กิจกรรมที่ต้องควบคุมและตรวจสอบอย่างเข้มงวด (Critical control)

1. การบันทึกใน Patient Transfer Record ให้ครบถ้วน กรณีที่ต้องส่งผู้ป่วยไปต่างแผนกและการเปลี่ยนทีมผู้ดูแล
2. การรับคำสั่งทางโทรศัพท์ ต้องทำให้ครบ 3 ขั้นตอน ได้แก่
 - 1) มีการบันทึกคำสั่งการรักษาใน Doctor order sheet (write down)
 - 2) อ่านทวนคำสั่งการรักษาให้แพทย์ผู้สั่งฟัง (read back) และยืนยันคำสั่ง
 - 3) แพทย์ผู้สั่งหรือทีมแพทย์เจ้าของไข้มาลงลายมือชื่อในตารางประทับรับคำสั่งการรักษาทางโทรศัพท์ที่ Doctor order sheet ภายใน 24 ชั่วโมง (cosign)

 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	นโยบาย เรื่อง : การสื่อสารโดยใช้ ISBAR	หน้า : 1/ 2 รหัสเอกสาร : NS-00-1-020-00 ทบทวนครั้งที่ : วันที่ทบทวน : วันที่อนุมัติ :
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลศิริราช		
ผู้ตรวจสอบ : หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลฯ		

WP การสื่อสารโดยใช้ ISBAR

- วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ผู้ป่วย
- ขอบเขต
ให้เป็นแนวปฏิบัติในการ
- คำจำกัดความ
ISBAR (ไอเอสบา)
B=Background, A=Assessment
ระหว่างกันของบุคลากรทางการแพทย์
- ความรับผิดชอบ
บุคลากรทางการแพทย์
นักวิชาการแพทย์ และผู้ที่มี
- เอกสารอ้างอิง
5.1 สถานะรับรอง
ผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราช พ.ศ.
- จรรยาบรรณ
ISBAR (ไอเอสบา) ประกอบ
6.1 I (Identification)
ระบุตัวผู้รายงาน
กำลังสนทนาด้วย
ระบุตัวผู้ป่วย
6.2 S (Situation) คือ
เกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนแผนของผู้ป่วย หรือ

 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	นโยบาย เรื่อง : การสื่อสารโดยใช้ ISBAR	หน้า : 1/ 2 รหัสเอกสาร : NS-00-1-020-00 ทบทวนครั้งที่ : วันที่ทบทวน : วันที่อนุมัติ :
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลศิริราช		
ผู้ตรวจสอบ : หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลฯ		ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสื่อสารระหว่างผู้ให้การดูแลเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของผู้ป่วย

2. ขอบเขต

ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการสื่อสาร (Communication) ระหว่างสหสาขาวิชาชีพ

3. คำจำกัดความ

ISBAR (ไอเอสบา) คือ อักษรย่อของขั้นตอนง่าย ๆ (I=Identification, S=Situation, B=Background, A=Assessment, R=Recommendation) ที่จะช่วยให้การสื่อสาร (communication) ระหว่างกันของบุคลากรทางการแพทย์มีประสิทธิภาพมากขึ้น

HR คณะฯ

ปี 2566



กลุ่มสาระ
FC04 ทักษะด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น
Soft Skills

Communication skills

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Service Excellence

การบริการที่เป็นเลิศ

เพื่อให้บุคลากรมีจิตบริการ (Service mind) และมีความรู้ความเข้าใจในการให้บริการ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Collaboration skills

การเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกัน

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในการทำงานร่วมกัน และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Mindfulness-Based Stress Management Program

การพัฒนาทักษะการรับมือกับความเครียด

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในการรับมือกับความเครียด และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Conflict Management

การบริหารความขัดแย้ง

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในการบริหารความขัดแย้ง และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปี 2567

FC04 SOFT SKILLS

FUNCTIONAL COMPETENCY

ทักษะด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น

หลักสูตรออนไลน์ พัฒนาทักษะที่ชาวศิริราชต้องมี

อบรมผ่าน **SELEcx** เริ่ม 2 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2567

ขอเชิญบุคลากรประจำหน่วยงาน เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรนี้ (บังคับ) ทั้ง 3 หลักสูตร

- 1 ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
Communication Skills
- 2 การบริการที่เป็นเลิศ
Service Excellence
- 3 การพัฒนาทักษะการรับมือกับความเครียด
Mindfulness-based Stress Management Program
- 4 การบริหารความขัดแย้ง
Conflict Management
- 5 การเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกัน
Collaboration Skills

เป้าหมาย: บุคลากรประเภทสนับสนุน ยกเว้นผู้ที่ได้รับการต่อสัญญาจ้าง หลังเกษียณอายุ

HRD Online Training

หลักสูตรอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
SI-UI SELEcx

สำหรับผู้ปฏิบัติงาน 109 ตำแหน่งเป้าหมาย



ปี 2568

FC04 SOFT SKILLS

FUNCTIONAL COMPETENCY

ทักษะด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น

หลักสูตรออนไลน์ พัฒนาทักษะที่ชาวศิริราชต้องมี

อบรมผ่านระบบ **SELEcx** เริ่ม 1 ธันวาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

ขอเชิญบุคลากรศิริราช เข้าร่วมอบรมเพิ่มศักยภาพ เรียนรู้ และพัฒนาตัวเอง

- 1 ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
Communication Skills
- 2 การบริการที่เป็นเลิศ
Service Excellence
- 3 การพัฒนาทักษะการรับมือกับความเครียด
Mindfulness-based Stress Management Program
- 4 การบริหารความขัดแย้ง
Conflict Management
- 5 การเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกัน
Collaboration Skills
- 6 เทคนิคการนำเสนอผลงาน
Presentation Techniques

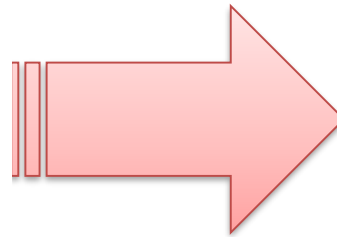
ติดตามข่าวสาร HR ได้ที่ เว็บไซต์ ผ่านทรัพยากรบุคคล และ FACEBOOK : SI-HR

หลักสูตรอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
http://hrd.sirirach.ac.th/ 4 1834, 9 9059, 9 8607

Hand-off



ward



OR

Operating Theatre Handoff

**Sending
Unit**

Perioperative Care

**Receiving
Unit**

Pre-op

Intra-op

Post-op

Handoff 1

**Ward to
Pre-
operative**

Handoff 2

**Preoperative
to
Intra-
operative**

Handoff 3

**During
Intra-
operative**

Handoff 4

**Intra-
operative to
Post-
anesthesia
Care Unit**

**Handoff 5
Post-
anesthesia
Care Unit to
Ward**

Communication-ISBAR

JACHO ได้ให้แนวทางการสื่อสารระหว่างสมาชิกของทีมผู้ให้บริการเกี่ยวกับสถานะของผู้ป่วยโดยใช้ **ISBAR** เป็นกรอบแนวคิดที่เป็นมาตรฐานของการสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมสุขภาพเกี่ยวกับอาการของผู้ป่วย

- ง่ายต่อการจดจำ
- มีประโยชน์ในการกำหนดกรอบการสนทนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ภาวะวิกฤติ

(JACHO, 2007; Gregory, 2006)

Communication-ISBAR

วัตถุประสงค์

1. ลดระยะเวลา
2. กระชับรัดกุม
3. เน้นประเด็นสำคัญ
ชัดเจน ใช้ข้อมูลเพื่อการ
ดูแลต่อเนื่อง

ISBAR Handover Framework

Published September 2020

CENA
College of Emergency Nursing Australia Ltd



www.cena.org.au/



I

IDENTIFICATION

Identify yourself and the patient. Confirm who you are speaking to.

Hello, this is Nurse Jane, I'm calling about patient Mr John Smith UR 123456. Are you his treating doctor?



S

SITUATION

What is going on with the patient?

Mr Smith developed central crushing chest pain at an 8/10 five minutes ago. He is currently haemodynamically stable.



B

BACKGROUND

Provide relevant history to give context to the situation.

Mr Smith presented yesterday for investigation of intermittent chest pain over the last month. His initial troponins were negative. He's awaiting a coronary angiogram.



A

ASSESSMENT

What is your relevant assessment of the patient? What do you believe is the issue?

I have conducted an ECG and administered 300mcg GTN as per policy. Mr Smith's pain is now 6/10 and his vital signs are normal.



R

RECOMMENDATIONS

What are you requesting? What does the patient require?

Could you please review Mr Smith ASAP - he requires further pain relief and repeat blood tests.

Communication-ISBAR

- มีการพัฒนาต่อยอดเป็น **"ISBARR"**

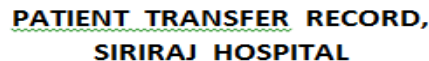
R = Read back หมายถึง การทวนซ้ำ (Kostiuk, 2015;Cudjoe, 2016)

R=Recommendation หมายถึง คำแนะนำ/หรือข้อเสนอแนะ /แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วย

❖ ใช้ในบางสถานการณ์ต้องรายงานทางโทรศัพท์ซึ่งถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงการดูแลรักษาจะต้องมีการอ่านทวนการรักษาหรือคำสั่งแพทย์ซ้ำเพื่อลดความผิดพลาดที่เกิดจากการฟังผิดหรือไม่ชัดเจน

Communication-ISBAR

Implementation of ISBAR in Perioperative care



Ward Tel.....
H.N. A.N.
Name Age.....
PRINT/NAME LABEL

MDR: ☐ No ☐ Yes

Date..... | Time..... Transfer from..... to.....
 Diagnosis..... Transfer for Admit/Procedure.....

Patient classification :

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ Critical <ul style="list-style-type: none"> ☐ On ventilator ☐ Unresponsive state ☐ Response to pain ☐ Glasgow coma score ≤ 8 ☐ Unstable hemodynamic with inotropics | ☐ Intermediate (No ventilator) <ul style="list-style-type: none"> ☐ Response to verbal command ☐ Risk for rapid change of status during transfer (Dilated pupil) ☐ Glasgow coma score 9-12 ☐ Stable hemodynamic with inotropics < 2 hrs. | ☐ General <ul style="list-style-type: none"> ☐ Awake ☐ Glasgow Coma Score 13 – 15 ☐ Stable hemodynamic with inotropics > 2 hrs ☐ Stable hemodynamic without inotropics |
|---|--|--|

Patient's status (before transfer) :

T.....°C	PR...../ min
RR...../ min	BP...../.....mmHg
O ₂ sat.....%	Pain Score
Pupil	
Right eye : Size.....mm	Reaction: Normal / Sluggish / Full
Left eye : Size.....mm	Reaction: Normal / Sluggish / Full

Breathing :

- ☐ Room air
- ☐ O₂.....liter / min : Via
- ☐ Cannular ☐ Mask / T-piece ☐ Tracheostomy tube
- ☐ Oro-endotracheal tube at.....
- ☐ Naso- endotracheal tube at

NPO :

- ☐
- No
- ☐
- Yes

Isolation :

Items sent with the patient :

Drugs : ☐ No ☐ Yes

- ☐ Dopamine.....
- ☐ Dobutamine.....
- ☐ Norepinephrine.....
- ☐ Adrenaline.....
- ☐ Heparin.....
- ☐ Furosemide.....
- ☐ Others

IV Fluid 1: Type.....Rate.....

IV Fluid 2 : Type.....Rate.....

Blood transfusion : Type.....Group.....
Rate.....

Isolation :

- ☐ No ☐ Yes.....

Mode of transfer :

- ☐ Stretcher ☐ Wheelchair ☐ Others.....

Assistance needed for transfer :

- ☐ Doctor..... ☐ RN
- ☐ PN..... ☐ Others

Patients ID	band in place	and legible
1	1	1
2	1	1
3	1	1
4	1	1
5	1	1
6	1	1
7	1	1
8	1	1
9	1	1
10	1	1
11	1	1
12	1	1
13	1	1
14	1	1
15	1	1
16	1	1
17	1	1
18	1	1
19	1	1
20	1	1
21	1	1
22	1	1
23	1	1
24	1	1
25	1	1
26	1	1
27	1	1
28	1	1
29	1	1
30	1	1
31	1	1
32	1	1
33	1	1
34	1	1
35	1	1
36	1	1
37	1	1
38	1	1
39	1	1
40	1	1
41	1	1
42	1	1
43	1	1
44	1	1
45	1	1
46	1	1
47	1	1
48	1	1
49	1	1
50	1	1
51	1	1
52	1	1
53	1	1
54	1	1
55	1	1
56	1	1
57	1	1
58	1	1
59	1	1
60	1	1
61	1	1
62	1	1
63	1	1
64	1	1
65	1	1
66	1	1
67	1	1
68	1	1
69	1	1
70	1	1
71	1	1
72	1	1
73	1	1
74	1	1
75	1	1
76	1	1
77	1	1
78	1	1
79	1	1
80	1	1
81	1	1
82	1	1
83	1	1
84	1	1
85	1	1
86	1	1
87	1	1
88	1	1
89	1	1
90	1	1
91	1	1
92	1	1
93	1	1
94	1	1
95	1	1
96	1	1
97	1	1
98	1	1
99	1	1
100	1	1

- ☐ No ☐ Yes ☐ White ☐ Blue ☐ Red

Signature..... (Recording staff)

Change of patient condition during transfer :

- ☐
- No
- ☐
- Yes

Remarks :

Other :

Special Concern / Recommendation :	
---	--

Signature..... (Transferring staff)

Time.....

Signature..... (Accepting staff)

Time.....



**PATIENT TRANSFER RECORD,
SIRIRAJ HOSPITAL**

MDR: ☐ No ☐ Yes

Ward.....Tel.....
H.N.....A.N.....
Name.....Age.....

PRINT/NAME LABEL

Date..... | Time Transfer from..... to.....

Diagnosis..... Transfer for Admit/Procedure.....

Patient classification :

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Critical <ul style="list-style-type: none">☐ On ventilator☐ Unresponsive state☐ Response to pain☐ Glasgow coma score ≤ 8☐ Unstable hemodynamic with inotropics | ☐ Intermediate (No ventilator) <ul style="list-style-type: none">☐ Response to verbal command☐ Risk for rapid change of status during transfer (Dilated pupil)☐ Glasgow coma score 9-12☐ Stable hemodynamic with inotropics < 2 hrs. | ☐ General <ul style="list-style-type: none">☐ Awake☐ Glasgow Coma Score 13 – 15☐ Stable hemodynamic with inotropics > 2 hrs☐ Stable hemodynamic without inotropics |
|--|--|--|

Patient's status (before transfer) :

T.....°C PR...../ min
RR...../ min BP...../.....mmHg
O₂ sat.....% Pain Score

Pupil
Right eye : Size.....mm Reaction: Normal / Sluggish / Full
Left eye : Size.....mm Reaction: Normal / Sluggish / Full

Breathing :

- ☐ Room air
- ☐ O₂.....liter / min : Via
- ☐ Cannular ☐ Mask / T-piece ☐ Tracheostomy tube
- ☐ Oro-endotracheal tube at.....
- ☐ Naso- endotracheal tube at

NPO :

☐ No ☐ Yes

Isolation :

Items sent with the patient :

Drugs : ☐ No ☐ Yes

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ☐ Dopamine..... | ☐ Dobutamine..... |
| ☐ Norepinephrine..... | ☐ Adrenaline..... |
| ☐ Heparin..... | ☐ Furosemide..... |
| ☐ Others | |

IV Fluid 1 : Type.....Rate.....

IV Fluid 2 : Type.....Rate.....

Blood transfusion : Type.....Group.....
Rate.....



PATIENT TRANSFER RECORD,
SIRIRAJ HOSPITAL

MDR : ☐ No ☐ Yes

Ward.....Tel.....
H.N.....A.N.....
Name.....Age.....
PRINT/NAME LABEL

Patient Transfer Record

Identification

Ward.....Tel.....
H.N.....A.N.....
Name.....Age.....
PRINT/NAME LABEL



PATIENT TRANSFER RECORD,
SIRIRAJ HOSPITAL

MDR : ☐ No ☒ Yes

Date..... | Time..... Transfer from..... to..... Situation

Diagnosis..... Transfer for Admit/Procedure

Background

Patient classification :

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ Critical
☐ On ventilator
☐ Unresponsive state
☐ Response to pain
☐ Glasgow coma score ≤ 8
☐ Unstable hemodynamic with inotropics | ☐ Intermediate (No ventilator)
☐ Response to verbal command
☐ Risk for rapid change of status during transfer (Dilated pupil)
☐ Glasgow coma score 9-12
☐ Stable hemodynamic with inotropics < 2 hrs. | ☐ General
☐ Awake
☐ Glasgow Coma Score 13 – 15
☐ Stable hemodynamic with inotropics > 2 hrs
☐ Stable hemodynamic without inotropics |
|---|--|--|

Patient's status (before transfer) :

T.....°C PR...../ min
RR...../ min BP...../.....mmHg
O₂ sat.....% Pain Score

Pupil
Right eye : Size.....mm Reaction: Normal / Sluggish / Full
Left eye : Size.....mm Reaction: Normal / Sluggish / Full

Items sent with the patient :

Drugs : ☐ No ☐ Yes

☐ Dopamine..... ☐ Dobutamine.....
☐ Norepinephrine..... ☐ Adrenaline.....
☐ Heparin..... ☐ Furosemide.....
☐ Others

Signature..... (Transferring)

Time.....

1058





PATIENT TRANSFER RECORD,
SIRIRAJ HOSPITAL

MDR : ☐ No ☐ Yes

Ward.....Tel.....
H.N.....A.N.....
Name.....Age.....
PRINT/NAME LABEL

Date..... | Time..... Transfer from..... to.....
Diagnosis..... Transfer for Admit/Procedure

Patient classification :

☐ Critical ☐ On ventilator ☐ Unresponsive state ☐ Response to pain ☐ Glasgow coma score ≤ 8 ☐ Unstable hemodynamic with inotropics	☐ Intermediate (No ventilator) ☐ Response to verbal command ☐ Risk for rapid change of status during transfer (Dilated pupil) ☐ Glasgow coma score 9-12 ☐ Stable hemodynamic with inotropics < 2 hrs	☐ General ☐ Awake ☐ Glasgow Coma Score 13 - 15 ☐ Stable hemodynamic with inotropics > 2 hrs
--	---	--

Patient's status (before transfer) :

T.....°C PR...../ min
RR...../ min BP.....mmHg
O₂ sat.....% Pain Score.....
Pupil
Right eye : Size.....mm Reaction: Normal / Sluggish / Full
Left eye : Size.....mm Reaction: Normal / Sluggish / Full

Breathing :
☐ Room air
☐ O₂.....liter / min : Via
☐ Cannular ☐ Mask / T-piece ☐ Tracheostomy tube
☐ Oro-endotracheal tube at.....
☐ Naso-endotracheal tube at.....

NPO :
☐ No ☐ Yes
Isolation :
☐ No ☐ Yes

Mode of transfer :
☐ Stretcher ☐ Wheelchair ☐ Others.....

Assistance needed for transfer :
☐ Doctor ☐ RN
☐ PN ☐ Others.....

Patients ID band in place and legible :
☐ No ☐ Yes ☐ White ☐ Blue ☐ Red

Signature..... (Recording)

Change of patient condition during transfer :
☐ No ☐ Yes

Remarks :

Signature..... (Transferring)
Time.....

1038



PATIENT TRANSFER RECORD,
SIRIRAJ HOSPITAL

MDR : ☐ No ☒ Yes

Date..... | Time..... Transfer from..... to.....

Diagnosis..... Transfer for Admit/Procedure

Patient classification :

☐ Critical ☐ On ventilator ☐ Unresponsive state ☐ Response to pain ☐ Glasgow coma score ≤ 8 ☐ Unstable hemodynamic with inotropics	☐ Intermediate (No ventilator) ☐ Response to verbal command ☐ Risk for rapid change of status during transfer (Dilated pupil) ☐ Glasgow coma score 9-12 ☐ Stable hemodynamic with inotropics < 2 hrs.	☐ General ☐ Awake ☐ Glasgow Coma Score 13 - 15 ☐ Stable hemodynamic with inotropics > 2 hrs ☐ Stable hemodynamic without inotropics
--	--	--

Patient's status (before transfer) :

T.....°C PR...../ min
RR...../ min BP.....mmHg
O₂ sat.....% Pain Score.....
Pupil
Right eye : Size.....mm Reaction: Normal / Sluggish / Full
Left eye : Size.....mm Reaction: Normal / Sluggish / Full

Items sent with the patient :

Drugs : ☐ No ☐ Yes
☐ Dopamine..... ☐ Dobutamine.....
☐ Norepinephrine..... ☐ Adrenaline.....
☐ Heparin..... ☐ Furosemide.....
☐ Others

Patient Transfer Record

Identification

Ward.....Tel.....
H.N.....A.N.....
Name.....Age.....
PRINT/NAME LABEL

Background

Assessment



PATIENT TRANSFER RECORD,
SIRIRAJ HOSPITAL

MDR : ☐ No ☐ Yes

Ward.....Tel.....
H.N.....A.N.....
Name.....Age.....
PRINT/NAME LABEL

Patient Transfer Record

Identification



PATIENT TRANSFER RECORD,
SIRIRAJ HOSPITAL

MDR : ☐ No ☒ Yes

Ward.....Tel.....
H.N.....A.N.....
Name.....Age.....
PRINT/NAME LABEL

Date..... | Time..... Transfer from..... to.....
Diagnosis..... Transfer for Admit/Procedure Situation.....

Background

Patient classification :

- ☐ Critical
- ☐ On ventilator
 - ☐ Unresponsive state
 - ☐ Response to pain
 - ☐ Glasgow coma score ≤ 8
 - ☐ Unstable hemodynamic with inotropics

- ☐ Intermediate (No ventilator)
- ☐ Response to verbal command
 - ☐ Risk for rapid change of status during transfer (Dilated pupil)
 - ☐ Glasgow coma score 9-12
 - ☐ Stable hemodynamic with inotropics < 2 hrs.

- ☐ General
- ☐ Awake
 - ☐ Glasgow Coma Score 13 - 15
 - ☐ Stable hemodynamic with inotropics > 2 hrs
 - ☐ Stable hemodynamic without inotropics

Patient's status (before transfer) :

T.....°C PR...../ min
RR...../ min BP...../.....mmHg
O₂ sat.....% Pain Score

Pupil

Right eye : Size.....mm Reaction: Normal / Sluggish / Full
Left eye : Size.....mm Reaction: Normal / Sluggish / Full

Items sent

Drugs : ☐ No
☐ Dopamine...
☐ Norepinephrine...
☐ Heparin...
☐ Others

Special Concern / Recommendation :

Assessment

Recommendation

Signature..... (Transferring)

Time.....

1058





PATIENT TRANSFER RECORD, SIRIRAJ HOSPITAL

สำเนา

1 MDR : ☐ No ☐ Yes

Ward.....Tel.....
H.N.....A.N.....
Name.....Age.....
PRINT/NAME LABEL

Date..... | Time..... Transfer from.....to.....

Diagnosis..... Transfer for Admit/Procedure

Patient classification :

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ Critical | ☐ Intermediate (No ventilator) | ☐ General |
| ☐ On ventilator | ☐ Response to verbal command | ☐ Awake |
| ☐ Unresponsive state | ☐ Risk for rapid change of status during transfer (Dilated pupil) | ☐ Glasgow Coma Score 13 – 15 |
| ☐ Response to pain | ☐ Glasgow coma score 9-12 | ☐ Stable hemodynamic with inotropics > 2 hrs |
| ☐ Glasgow coma score ≤ 8 | ☐ Stable hemodynamic with inotropics < 2 hrs. | ☐ Stable hemodynamic without inotropics |

Patient's status (before transfer) :

T.....°C PR...../ min
RR...../ min BP...../.....mmHg
O₂ sat.....% Pain Score

Pupil
Right eye : Size.....mm Reaction: Normal / Sluggish / Full
Left eye : Size.....mm Reaction: Normal / Sluggish / Full

Breathing :

- ☐ Room air
- ☐ O₂.....liter / min : Via
☐ Cannular ☐ Mask / T-piece ☐ Tracheostomy tube
☐ Oro-endotracheal tube at.....
☐ Naso- endotracheal tube at

NPO :

☐ No ☐ Yes

Isolation :

☐ No ☐ Yes

Mode of transfer :

☐ Stretcher ☐ Wheelchair ☐ Others.....

Assistance needed for transfer :

☐ Doctor..... ☐ RN.....
☐ PN..... ☐ Others.....

Patients ID band in place and legible :

☐ No ☐ Yes ☐ White ☐ Blue ☐ Red

Signature..... (Recording staff)

Change of patient condition during transfer :

☐ No ☐ Yes

Remarks :

.....

Signature..... (Transferring staff)

Time.....

1058

6

Items sent with the patient :

Drugs : ☐ No ☐ Yes
☐ Dopamine..... ☐ Dobutamine.....
☐ Norepinephrine..... ☐ Adrenaline.....
☐ Heparin..... ☐ Furosemide.....
☐ Others

IV Fluid 1 : Type.....Rate.....
 IV Fluid 2 : Type.....Rate.....

Blood transfusion : Type.....Group.....
 Rate.....

Other : 2

Special Concern / Recommendation :

3

.....

Signature..... (Accepting staff)

Time.....

การบันทึกข้อมูลใน ใบ Patient Transfer record

ประเด็นที่พบบ่อยๆ

- 1) MDR(ดื้อยา)
- 2) Other
- 3) Special concern/Recommendation
- 4) Assistance needed tor transfer
- 5) Change of patient condition during transfer
- 6) Signature (Transferring staff)

กรณีไม่มีประเด็นให้เขียน

N/A = *not applicable* (นำมาใช้ไม่ได้), *not available* (ไม่มีอยู่, ไม่ปรากฏ, หาไม่ได้)
 ใช้เพื่อแสดงว่า ช่องที่ไม่ให้ข้อมูลนั้น เพราะไม่อาจนำมาใช้แก่กรณีที่เหมาะสมได้ หรือไม่มี ไม่ปรากฏ หรือหาข้อมูลไม่ได้ อย่างไม่อย่างหนึ่ง



Siriraj Surgical Safety Checklist

Before induction of anaesthesia

(With at least nurse and anaesthetist)

1. Has the patient confirmed his/her identity, site, procedure, and consent?
 - ☐ Yes
2. Is the site marked?
 - ☐ Yes
 - ☐ Not applicable
3. Is the anaesthesia machine and medication check complete?
 - ☐ Yes
4. Is the pulse oximeter on the patient and functioning?
 - ☐ Yes
5. Does the patient have a known allergy?
 - ☐ No
 - ☐ Yes
6. Does the patient have a difficult airway or aspiration risk?
 - ☐ No
 - ☐ Yes, and equipment/assistance available
7. Does the patient have a risk of >500ml blood loss (7ml/kg in children)?
 - ☐ No
 - ☐ Yes, and adequate IVs/central access and fluids planned

Sign.....

Before skin incision

(With nurse, anaesthetist and surgeon)

- ☐ 8. Confirm all team members have introduced themselves by name and role.
- ☐ 9. Confirm the patient's name, procedure, and where the incision will be made.
10. Has antibiotic prophylaxis been given within the last 60 minutes?
 - ☐ Yes
 - ☐ Not applicable
11. Anticipated Critical Events: To Surgeon
 - ☐ What are the critical or non-routine steps?
 - ☐ How long will the case take?
 - ☐ What is the anticipated blood loss?
12. Anticipated Critical Events: To Anaesthetist
 - ☐ Are there any patient-specific concerns?
13. Anticipated Critical Events: To Nursing Team
 - ☐ Has sterility (including indicator results) been confirmed?
 - ☐ Are there equipment issues or any concerns?
14. Is essential imaging displayed?
 - ☐ Yes
 - ☐ Not applicable

Sign.....

Before patient leaves operating room

(With nurse, anaesthetist and surgeon)

- Nurse Verbally Confirms:
- ☐ 15. The name of the procedure
 - ☐ 16. Completion of instrument, sponge and needle counts
 - ☐ 17. Specimen labelling (read specimen labels aloud, including patient name)
 - ☐ Yes
 - ☐ Not applicable
 - ☐ 18. Whether there are any equipment problems to be addressed
 - ☐ 19. What are the key concerns for recovery and management of this patient?
 - To Surgeon ☐ No ☐ Yes
 - To Anaesthetist ☐ No ☐ Yes
 - To Nurse ☐ No ☐ Yes

Sign.....

ชื่อ.....นามสกุล.....

อายุ.....HN.....

ห้องผ่าตัด.....วันที่.....



Siriraj Surgical Safety Checklist

***Stop การใช้ paper SSSC ม.ค.63**

ดิฉัน(ชื่อ)..... เป็น Circulating Nurse ขอทำ Patient Safety Checklist ก่อนการระงับความรู้สึก

ก. ในห้องผ่าตัดก่อนเริ่มให้การระงับ

ความรู้สึกรับ : Sign in

(อย่างน้อย พยาบาล และวิสัญญีแพทย์/พยาบาล)

- ได้ยืนยันการระบุตัวผู้ป่วย ตำแหน่ง ชนิดของเหตุการณ์ รวมทั้งการขอความยินยอมในการทำเหตุการณ์แล้วหรือไม่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
- ได้ทำเครื่องหมายระบุข้างที่จะทำผ่าตัดหรือไม่ ☐ ใช่ ☐ ไม่จำเป็นต้องทำ
- ได้ตรวจสอบเครื่องมือและยาที่จะใช้ในการดมยา/ระงับความรู้สึก แล้วหรือไม่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
- ได้ติด pulse oximeter กับตัวผู้ป่วย และตรวจสอบว่าเครื่องทำงานปกติแล้วหรือไม่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
- ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยาหรือแพ้อาหารหรือไม่ และหากมีสิ่งที่แพ้คืออะไร ☐ ไม่แพ้ ☐ แพ้
- ผู้ป่วยมีปัญหาในการดูทางเดินหายใจ หรือมีความเสี่ยงในการสูดสำลักหรือไม่ ☐ ไม่มี ☐ มี, ได้เตรียมอุปกรณ์ และผู้ช่วยพร้อม
- ผู้ป่วยมีความเสี่ยงที่จะเสียเลือดมากกว่า 500 มิลลิลิตร หรือ หากเป็นเด็กจะเสียเลือดมากกว่า 7 มิลลิลิตรต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมหรือไม่ ☐ ไม่ ☐ มี และได้เปิดหลอดเลือด เตรียมเลือดไว้พร้อมแล้วค่ะ

ลงชื่อ (ผู้เขียน)

ข. ก่อนเริ่มทำหัตถการ : Time out

(พยาบาล วิสัญญีแพทย์/พยาบาล และศัลยแพทย์)

- ยืนยันว่าสมาชิกทุกคนในที่นี้ได้แนะนำตัวและบทบาทหน้าที่แล้ว
- ยืนยัน ชื่อ-สกุลของผู้ป่วย... ชื่อหัตถการ...และตำแหน่งที่จะลงแผลผ่าตัด.....
- ผู้ป่วยได้รับยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อภายใน 60 นาทีที่ผ่านมาแล้วหรือไม่ ☐ ให้แล้ว ☐ ไม่จำเป็นต้องให้
- สำหรับศัลยแพทย์: มีขั้นตอนสำคัญหรือที่แตกต่างจากที่เคยปฏิบัติมาหรือไม่ จะใช้เวลาผ่าตัดนานเท่าใด และจะเสียเลือดมากน้อยเพียงใด
- สำหรับทีมวิสัญญี: ผู้ป่วยมีประเด็นที่ต้องระวังเป็นพิเศษหรือไม่
- สำหรับทีมพยาบาล: ยืนยันว่าเครื่องมือปลอดเชื้อ มีประเด็นที่ควรระวังเกี่ยวกับเครื่องมือหรือไม่
- มีฟิล์มเอกซเรย์ ที่จำเป็นต้องแสดงหรือไม่ ☐ มี ได้แสดงอยู่ในห้องผ่าตัดแล้ว ☐ ไม่จำเป็นต้องมี

ลงชื่อ (ผู้เขียน)

ค. ก่อนย้ายผู้ป่วยออกจากห้องผ่าตัด :

Sign out

(พยาบาล วิสัญญีแพทย์/พยาบาล และศัลยแพทย์)

- ทีมได้ทำผ่าตัด..... ถูกต้องหรือไม่
- นับเครื่องมือ ผ้าซับโลหิต ของมีคม ครบแล้วหรือไม่
- การเขียนฉลากสิ่งส่งตรวจครบ/ถูกต้องหรือไม่ ☐ ใช่ ให้อ่านฉลากที่เขียน ระบุชนิดของสิ่งส่งตรวจ จำนวน และชื่อผู้ป่วย ☐ ไม่มีสิ่งส่งตรวจ
- เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้มีปัญหาหรือไม่
- ศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์/พยาบาล และพยาบาลผ่าตัด ทบทวนประเด็น/ปัญหาสำคัญที่ต้องดูแลเป็นพิเศษหลังผ่าตัดว่ามีหรือไม่
- อาจารย์ผ่าตัด ☐ ไม่มี ☐ มี
- อาจารย์ดมยา ☐ ไม่มี ☐ มี
- พยาบาลผ่าตัด ☐ ไม่มี ☐ มี

ลงชื่อ (ผู้เขียน)

Briefing ทีมใหญ่

1. แผนผ่าตัด.....
2. ผู้ป่วย (Patient ID) : ชื่อ-นามสกุล.....อายุ.....
3. ชื่อการผ่าตัด.....
4. ตำแหน่ง.....ข้าง.....Mark site OK.
5. การจัดท่า (Position).....
6. ใช้เวลาผ่าตัดประมาณ.....
7. ให้ antibiotic..... No..... Yes...ชื่อ.....dose...ครบ Redosing ทุก...
8. Imaging ถูกต้อง*..... No..... Yes.....
9. ใช้อุปกรณ์พิเศษ*..... No..... Yes.....
10. ต้องส่ง frozen section* No..... Yes.....
11. Critical steps/concerns ที่ต้องการให้ทีมทราบและเตรียมการ (แต่ละทีมระบุ)
 - ศัลยแพทย์
 - วิสัญญีฯ
 - พยาบาล

[link to Siriraj Surgical Safety Checklist : Audit form](#)

ความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด (Safe surgery)

กระบวนการ	Brief แต่ละทีม	Brief ทีมใหญ่			
		Sign in	Time out		Sign out
ช่วงเวลา	แต่ละทีมดำเนินการ	ผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัด	ก่อนลงมือผู้ป่วย	ก่อนเริ่มเปิด	ก่อนผู้ป่วยออกจากห้องผ่าตัด
ผู้รับผิดชอบ	(nurse (A-C), anesthesia team (เอกสาร 1 column ซ้าย), surgical team (เอกสาร 2))	ทีมวิสัญญีฯ กับผู้ป่วย (เอกสาร 1 column กลาง) Surgical resident/staff กับทีม - นักรุ่น*	Circulating nurse - กล่าวนำหัวข้อ check - ผู้เกี่ยวข้องหยุดฟังและตอบ	Circulation nurse - สรุป - ผู้เกี่ยวข้อง หยุดฟัง	Circulating nurse - กล่าวนำหัวข้อ check - ผู้เกี่ยวข้องหยุดฟังและตอบ
หัวข้อ	(รายละเอียดตามเอกสาร Briefing แต่ละทีม และระหว่างทีมก่อนเข้าห้องผ่าตัด)	1. แนะนำทีม 2. ผู้ป่วย (Patient ID): ชื่อ-นามสกุล...อายุวันเดือนปีเกิด 3. ชื่อผ่าตัด..... 4. ตำแหน่ง.....ข้าง..... Mark site OK. 5. การจัดท่า (Position) 6. Imaging ถูกต้อง* ☐ No... ☐ Yes... 7. ใช้เวลาผ่าตัดประมาณ..... 8. ใช้อุปกรณ์พิเศษ* ☐ No... ☐ Yes... 9. ให้ antibiotic... ☐ No... ☐ Yes... ชื่อ.....dose...ครบ Redosing ทุก..... 10. ต้องส่ง frozen section* ☐ No... ☐ Yes... 11. Critical steps/concerns ที่ต้องการให้ทีมทราบและเตรียมการ (แต่ละทีมระบุ) - ศัลยแพทย์ - วิสัญญีฯ - พยาบาล	1. ได้แนะนำตัวของทีมแล้ว 2. ผู้ป่วย (Patient ID): ชื่อ-นามสกุล..... อายุวันเดือนปีเกิด 3. ชื่อผ่าตัด..... 4. ตำแหน่ง.....ข้าง..... 5. ให้ antibiotic เรียบร้อยแล้ว 6. เครื่องมือ/เครื่องใช้พิเศษ 7. กรณีที่มีผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงตามแพทย์..... 8. การส่งชิ้นเนื้อ - จำนวน.....ชิ้น - Patho ชื่อ specimen..... - Culture ชื่อ specimen..... - Frozen section	☐ เครื่องมือ ครบถ้วน ☐ Swab/ Sponge count ครบถ้วน	1. Final diagnosis..... 2. Operation..... 3. วิเคราะห์..... 4. เครื่องมือ ครบ 5. Swab/Sponge count ครบ 6. Postoperation concern (ต้องทำ) - ศัลยแพทย์..... - วิสัญญี..... - พยาบาล..... 7. กรณีที่มีผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงตามแพทย์..... 8. การส่งชิ้นเนื้อ - จำนวน.....ชิ้น - Patho ชื่อ specimen..... - Culture ชื่อ specimen..... - Frozen section
หมายเหตุ	- ไม่มี Briefing ของแต่ละทีม - ถ้ามีการรับส่งมอบ/เปลี่ยนทีม เน้น hand off and hand over: พยาบาล (เอกสาร D, E) วิสัญญี (เอกสาร 1 column ขวา) * สามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของบริบทการผ่าตัดในแต่ละภาควิชา				

Page 2 of 8

Briefing ทีมใหญ่

- แนะนำทีม.....
- ผู้ป่วย (Patient ID) : ชื่อ-นามสกุล.....อายุ.....
- ชื่อการผ่าตัด.....
- ตำแหน่ง.....ข้าง.....Mark site OK.
- การจัดท่า (Position).....
- ใช้เวลาผ่าตัดประมาณ.....
- ให้ antibiotic..... ☐ No..... ☐ Yes...ชื่อ.....dose...ครบ Redosing ทุก...
- Imaging ถูกต้อง*..... ☐ No..... ☐ Yes.....
- ใช้อุปกรณ์พิเศษ*..... ☐ No..... ☐ Yes.....
- ต้องส่ง frozen section* ☐ No..... ☐ Yes.....
- Critical steps/concerns ที่ต้องการให้ทีมทราบและเตรียมการ (แต่ละทีมระบุ)
 - ศัลยแพทย์
 - วิสัญญีฯ
 - พยาบาล

Audit Briefing ทีมใหญ่

link to Siriraj Surgical Safety Checklist : Audit form

Briefing

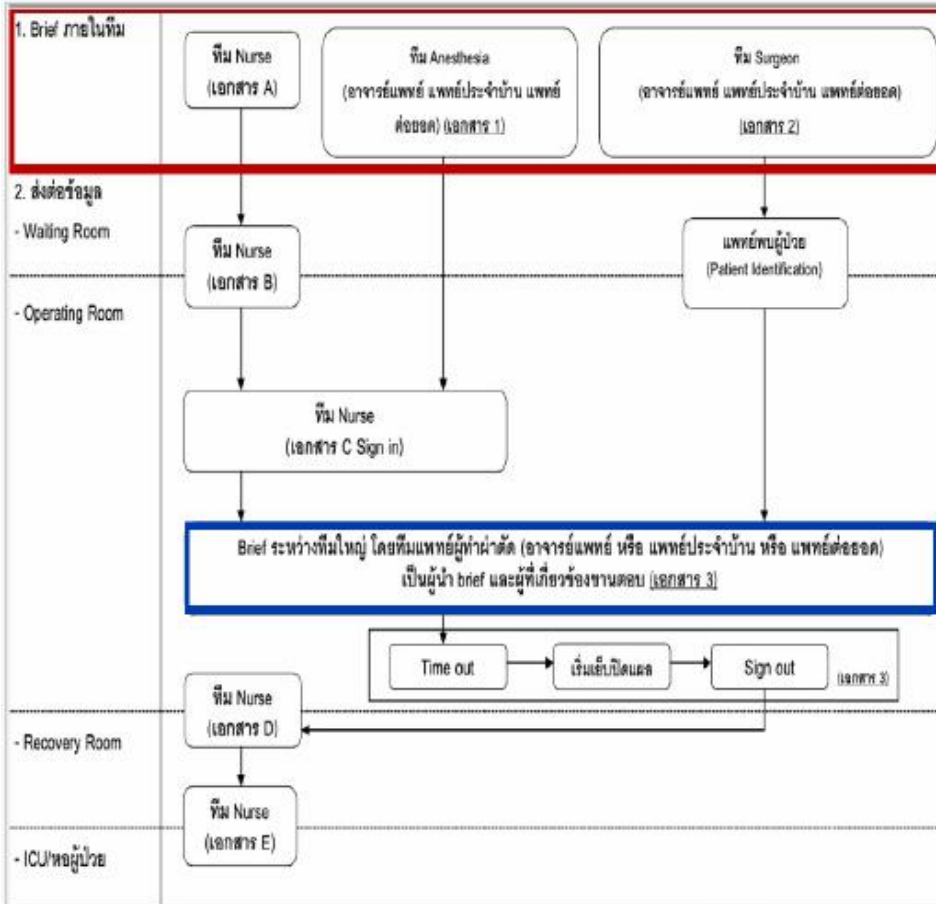
Sign in

Timeout

Sign out

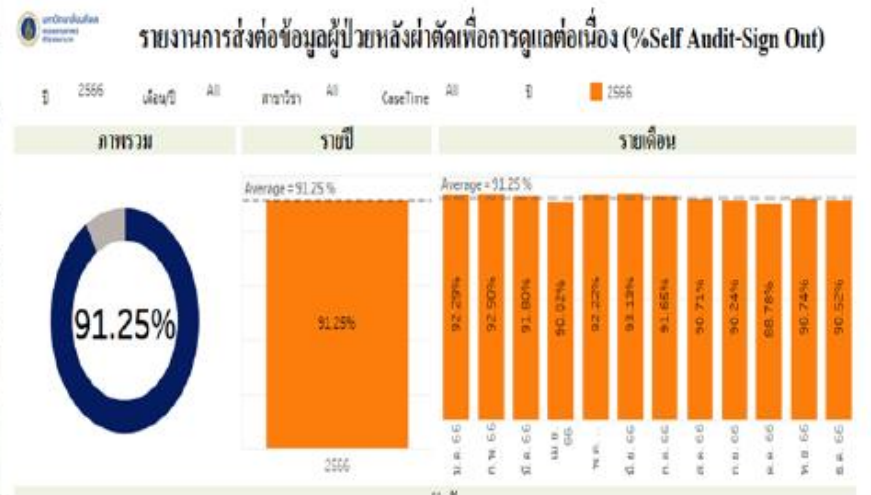
Debriefing

Brief ทีมใหญ่	Time out		Sign out
ก่อนเริ่มการผ่าตัด (Surgical resident/staff กับทีม)	ก่อนลงมือผู้ป่วย	เริ่มเย็บปิด	ก่อนผู้ป่วยออกจากห้อง ผ่าตัด
แพทย์ผ่าตัด brief - นำสรุป* (ในลักษณะเล่าตามลำดับขั้นตอน) - ผู้เกี่ยวข้องหยุดฟัง และตอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง	Circulating nurse - กล่าวนำหัวข้อ check - ผู้เกี่ยวข้องหยุดฟังและตอบ	Circulating nurse - สรุป - ผู้เกี่ยวข้อง หยุดฟัง	Circulating nurse - กล่าวนำหัวข้อ check - ผู้เกี่ยวข้องหยุดฟังและตอบ
1. แนะนำทีม 2. ผู้ป่วย (Patient ID): ชื่อ-นามสกุล.....อายุ..... 3. ชื่อการผ่าตัด..... 4. ตำแหน่ง.....ข้าง..... Mark site OK. 5. การจัดท่า (Position) 6. Imaging ถูกต้อง*... ☐ No... ☐ Yes... 7. ใช้เวลาผ่าตัดประมาณ..... 8. ให้อุปกรณ์พิเศษ*... ☐ No... ☐ Yes... 9. ให้ antibiotic... ☐ No... ☐ Yes...ชื่อ..... dose....ครบ Redosing ทุก.. 10. ต้องส่ง frozen section* ☐ No... ☐ Yes.. 11. Critical steps/concerns ที่ต้องการให้ทีม ทราบและเตรียมการ (แต่ละทีมระบุ) - ศัลยแพทย์ - วิสัญญีฯ - พยาบาล	อาจารย์คะ ทำ time out ค่ะ 1. ผู้ป่วย ชื่อ-นามสกุล..... 2. ชื่อผ่าตัด..... 3. ตำแหน่ง.....ข้าง.. 4. Patient identification แพทย์ตอบ • ทำแล้ว • ถ้ายังไม่ได้ทำให้ทำดังนี้ - Check wristband - ดูแฟ้ม - ดู film 5. ให้ antibiotic เรียบร้อยแล้ว (วิสัญญีฯ ตอบ ถ้าเป็นผู้ให้) 6. เครื่องมือพิเศษ พร้อม 7. อวัยวะเทียมพร้อม	1. เครื่องมือ ครบ 2. Swab/ Sponge count ครบ 3. ใส่ drain* (ถ้าเกี่ยวข้อง)	1. Post-op diagnosis..... 2. Operation..... 3. เครื่องมือ ครบ 4. Swab/Sponge count ครบ 5. สิ่งที่ต้องดูแลหลังผ่าตัด เป็นพิเศษ (ต้องทำ) ที่ RR, ICU, ward - ศัลยแพทย์..... - วิสัญญีฯ..... - พยาบาล..... 6. มีส่งชิ้นเนื้อหรือไม่ ถ้ามี - จำนวน.....ชิ้น. - Patho ชื่อ specimen.. - Culture ชื่อ specimen - Frozen section



SSSC: Siriraj Surgical Safety Checklist

- Audit การทำ Sign out เริ่ม 7 ก.พ.65



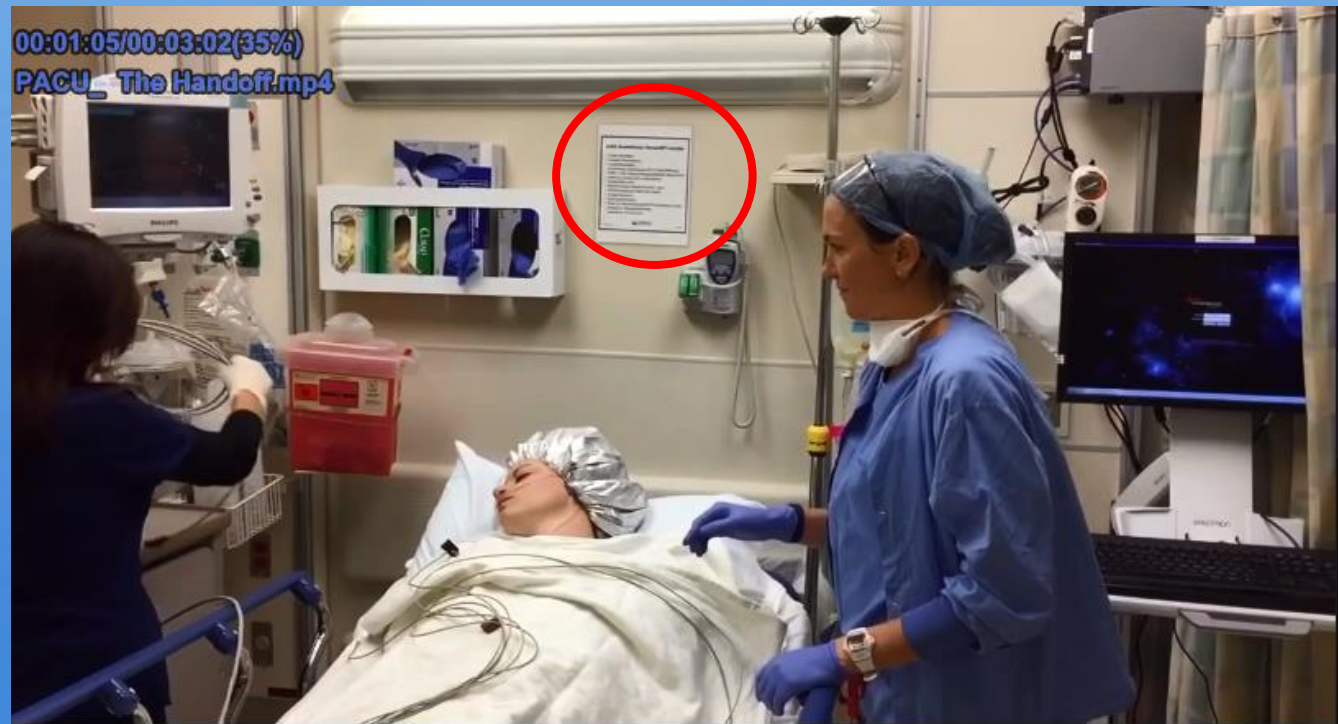
กระดานสื่อสาร OK SWAB / เช็ม มีด ด้วย

Name	Age	HN.	Remark
Diagnosis	Operation		
Items	Amount	Pack	First count Second count Final count
			In out Total Total Total
Roll swab			scrub clr scrub clr scrub clr scrub clr
Gauze X-ray			scrub clr scrub clr scrub clr scrub clr
Abdominal -Swab			scrub clr scrub clr scrub clr scrub clr
Eye swab			scrub clr scrub clr scrub clr scrub clr
Throat swab			scrub clr scrub clr scrub clr scrub clr
Needle			scrub clr scrub clr scrub clr scrub clr
Blade			scrub clr scrub clr scrub clr scrub clr

กระดานสื่อสาร
OR.General

PACU: The Handoff

Using cognitive aids like handoff/transfer checklists to reduce variability when transferring patient care, improves patient care. The checklist is used to verify that the essential points of care are discussed. Everybody forgets something.



AAG Anesthesia Handoff/Transfer

- Case Identifiers
- Contact Precautions
- Anesthesiologist
- Anesthesia type/Airway (ETT/LMA/Difficulty)
- PMH - ASA Status/Allergies/Mental Status/OSA
- Intra-Op problems/Complications
- Fluids/EBL/UOP
- Blood Product Status/Current Labs
- PONV/Relaxants/ABx/Pain Meds
- Drugs/Infusions
- IVs/Lines/Devices
- Post Op Plans/Disposition/Physiological Goals
- Surgeon's Requests/Airway
- Questions & Concerns

A close-up photograph showing a person's hand placing a light-colored wooden block onto another identical block. The top block has the word 'PATIENT' printed in bold, black, sans-serif capital letters. The bottom block has the word 'SAFETY' printed in the same style. The background is a soft-focus white surface with a small green plant on the left and a white pill on the right.

PATIENT

SAFETY